



Guia de Preparo Pré-operatório

Documento educacional baseado em referências reconhecidas de segurança do paciente. Não representa protocolo de uma instituição específica.

Finalidade

Apresentar orientações gerais de preparo compatíveis com práticas perioperatórias. O preparo definitivo deve seguir as instruções da equipe cirúrgica/anestésica e o protocolo do serviço.

1. Jejum

O tempo de jejum depende do tipo de alimento, idade, condição clínica, procedimento e técnica anestésica. O paciente deve seguir a orientação individual fornecida pela equipe.

Como referência internacional para pacientes saudáveis em procedimentos eletivos, líquidos claros podem ser permitidos até 2 horas antes; refeição leve ou leite não humano costuma exigir pelo menos 6 horas; refeições com alimentos gordurosos, frituras ou carne podem exigir 8 horas ou mais.

Esses intervalos não devem ser aplicados automaticamente a todos os pacientes. Condições como alterações do esvaziamento gástrico, gestação, obesidade, diabetes, urgência e outras situações podem exigir avaliação específica.

Se o paciente não cumpriu o jejum orientado, a equipe anestésica/cirúrgica deve ser informada; o profissional não deve simplesmente redefinir o horário por conta própria.

2. Medicamentos

O paciente deve informar todos os medicamentos, fitoterápicos e suplementos em uso.

Não orientar suspensão ou manutenção de medicamentos por conta própria. Anticoagulantes, antiagregantes, medicamentos para diabetes e outros fármacos podem exigir plano individual definido pela equipe responsável.

Quando houver dúvida sobre a última dose ou orientação recebida, registrar a informação e comunicar a equipe.

3. Higiene e pele

O preparo da pele deve seguir orientação institucional. O paciente deve evitar intervenções não orientadas que possam causar lesões cutâneas.

Quando a remoção de pelos for necessária, ela deve seguir protocolo do serviço; raspagem com lâmina imediatamente antes da cirurgia não deve ser realizada de forma rotineira por iniciativa do paciente.

Lesões, infecções ou alterações de pele próximas ao local do procedimento devem ser comunicadas à equipe.

4. Adornos, próteses e objetos

Jóias, piercings, próteses removíveis, lentes de contato e outros itens devem ser manejados conforme o tipo de procedimento e protocolo institucional.

Objetos retirados devem ser identificados e entregues ao responsável ou armazenados conforme rotina do serviço.

5. Chegada ao serviço

O paciente deve levar os documentos e exames solicitados e informar mudanças recentes de saúde, febre, sintomas respiratórios, novas medicações, alergias ou intercorrências.

Orientações específicas da equipe assistencial prevalecem sobre recomendações gerais deste guia.

Referências-base

- Ministério da Saúde / ANVISA / Fiocruz - Protocolos Básicos de Segurança do Paciente: identificação do paciente, cirurgia segura, prevenção de quedas e segurança no uso de medicamentos.
- RDC ANVISA nº 36/2013 - ações para segurança do paciente em serviços de saúde.
- Conselho Federal de Medicina - Resolução CFM nº 1.638/2002 (prontuário médico) e Recomendação CFM nº 1/2016 (consentimento livre e esclarecido).
- American Society of Anesthesiologists - Practice Guidelines for Preoperative Fasting (referência internacional para jejum em procedimentos eletivos: aplicação depende da avaliação anestésica e do protocolo institucional).

Nota de uso: material preparado para projeto acadêmico de RAG. Na assistência real, prevalecem legislação vigente, protocolos institucionais e avaliação dos profissionais responsáveis.